

15 - 07- RUBÉOLE ET GROSSESSE - Pr. BASSIR

(0:01 - 0:25)

Bonjour, aujourd'hui on va voir les infections et grossesses. On va entamer les infections les plus importantes qui ont des retentissements plus ou moins importants sur la grossesse, sur la femme enceinte et sur son fœtus. Je commence par la première infection, c'est la rubeole et grossesse.

(0:26 - 0:39)

La rubeole est une maladie virale. C'est une maladie bénigne chez l'enfant et l'adulte. Le risque tératogène est très important lorsqu'il y a une primo-infection rubeolique au cours de la grossesse.

(0:40 - 1:16)

D'où l'intérêt d'un dépistage systématique et d'ailleurs la sérologie de la rubeole fait partie de la sérologie demandée systématiquement au cours de la grossesse. On veut attirer l'attention sur l'intérêt de la vaccination de toutes les femmes qui ont une sérologie négative et qui sont en âge de procréation. L'épidémiologie, l'agent pathogène, c'est un virus ARN de la famille de Togaviridae, du genre rubivirus.

(1:17 - 1:33)

L'homme représente l'hôte naturel. La transmission se fait par voie respiratoire et la période de contagiosité, c'est 8 jours avant et 8 jours après l'éruption. Le temps d'incubation est de 16 jours.

(1:34 - 2:05)

C'est une maladie cosmopolite, endémique, survenant au printemps sous les climats tempérés, qui évolue de façon cyclique avec des cycles tous les 2 ou 3 ans. L'évolution sérologique, donc après le contact par le virus de la rubeole, on a une apparition immédiate et très importante d'IgM. Puis une apparition qui est progressive, une augmentation progressive d'IgG.

(2:05 - 2:28)

Après 6 semaines, les IgM disparaissent et les IgG restent à un taux constant pendant toute la vie. C'est une maladie immunisante, donc on a une disparition d'IgM et d'IgG qui sont constants. La pathogénie.

(2:29 - 2:54)

Après inhalation, le virus se multiplie au niveau des muqueuses respiratoires, puis des ganglions cervicaux et puis il gagne la circulation générale. La viremie détectable est de 7 jours avant l'éruption. Les polyadénopathies présentes correspondent au site de multiplication secondaire du

virus.

(2:54 - 3:21)

L'éruption apparaît en même temps que la production des anticorps. En ce qui concerne les signes cliniques, généralement la rubeole c'est une maladie qui est bénigne chez l'enfant ou bien chez le sujet adulte. Et comme signe clinique, pathognomique, c'est l'exantème qui est présent au niveau de la face puis le reste du corps.

(3:21 - 3:36)

Il prédomine au niveau du cou, du tronc, de la racine des membres, aux plis de flexion. Et la particularité c'est qu'il respecte les faces palmoplantaires et le cuir chevelu. Il n'y a pas de prurite.

(3:37 - 3:54)

On a un syndrome fébrile modéré, des anéombaties multiples qui prédominent dans la région cervicale postérieure. Les arthragies peuvent persister une à deux semaines après la fin de l'éruption. 50% au moins des rubeoles sont asymptomatiques.

(3:56 - 4:13)

Et 50% des rubeoles cliniques ne sont pas des rubeoles. Donc, il faut une confirmation sérologique qui est indispensable pour poser le diagnostic. La transmission materno-foetale.

(4:13 - 4:48)

Si la primo-infection s'accompagne d'une vérimie, les modalités de transmission mère-enfant, il se fait au cours d'une primo-infection maternelle avec une vérimie importante. Lors d'un passage trans-placentaire et une multiplication du virus dans le placenta ou le fœtus, ou bien l'embryon. Le risque de transmission, il est très important avant une semaine d'amenorrhée.

(4:48 - 5:00)

Elle est à peu près de 90%. Vers 25 semaines d'amenorrhée, elle est à peu près de 25%. La fin de grossesse, elle est inférieure à 10%.

(5:01 - 5:11)

Les effets de la rubeose sur la grossesse. On a un risque d'avortement spontané. Et le risque le plus important, c'est le risque malformatif.

(5:12 - 5:27)

Ou bien le risque d'embryopathie. Les malformations peuvent atteindre le cœur. Avec, comme

malformation, la persistance du canal artériel, une sténose de l'artère pulmonaire.

(5:28 - 5:59)

On peut avoir une atteinte de l'œil sous forme de cataractes, de rétinopathie, de mycrophthalmie et de cécité. L'oreille, une surdité de perception, les dents, des anomalies de la taille, de forme et une hypoplasie de l'émail. Et l'embryopathie, c'est le syndrome de Grecque qui s'accompagne d'une atteinte neurologique possible, une microcéphalie, des convulsions et un retard psychomoteur.

(5:59 - 6:21)

C'est ce qui fait que c'est une maladie grave, surtout s'il y a une prime ou infection au cours de la grossesse. Je répète, le risque de transmission est très important avant une semaine d'amenorrhée, qui avoisine à peu près 100%. Entre 11 et 12 semaines d'amenorrhée, il est de 50%.

(6:21 - 6:43)

Et au-delà de 13 semaines, il y a un risque de surdité. Si la prime ou infection survient après 18 semaines d'amenorrhée, le risque d'embryopathie est de zéro. Donc, le dépistage avant la conception ou bien au cours du premier trimestre.

(6:43 - 7:26)

C'est-à-dire, si on voit la femme après 18 semaines d'amenorrhée, à ce moment-là, les malformations sont déjà présentes et vraiment, ça ne sert à rien de demander une sérologie. Le risque de photopathie, c'est le risque de rébellion congénitale évolutive très contagieuse. On peut avoir un retard de croissance intra-utérin, une encéphalite, une pneumonie interstitielle souvent mortelle, une atteinte hématologique sous forme d'hépatosplénomégalie, de purpérotrombopénique, d'anémie hémorragique responsable d'un nictère sévère.

(7:28 - 7:56)

Chose très importante, c'est l'interprétation des résultats. Il faut savoir, si on a des IgG positifs, ça veut dire que la femme est immunisée. C'est une immunisation antérieure.

Il faut rassurer la patiente. De préférence, il faut demander une deuxième sérologie après trois semaines pour confirmer l'immunisation. Normalement, on doit avoir un taux stable d'IgG.

(7:57 - 8:16)

Si les IgG sont négatifs, la patiente n'est pas immunisée. Donc, il faut refaire l'IgG entre trois semaines et un mois plus tard. Demandez un deuxième dosage, voire un taux d'IgM pour voir s'il y a une primo-infection ou pas.

(8:18 - 8:39)

La conduite à tenir, d'abord il faut confirmer l'atteinte fœtale, qui peut être confirmée de deux façons. Soit la recherche d'IgM dans le sens fœtal, mais on ne le fait pas avant 22 semaines. Soit la recherche du génome viral dans le liquide amniotique, qui reste difficile parce que c'est un virus qui est fragile.

(8:40 - 9:03)

On ne peut pas le faire avant 18 semaines d'amenorrhée. Et il faut attendre six semaines entre la sarroconversion et le prélèvement pour identifier le génome, l'ARN viral. Pendant la grossesse, il faut demander la première sérologie le plus tôt possible, avant huit semaines d'amenorrhée.

(9:04 - 9:34)

Ça veut dire, au cours du premier trimestre, au cours de la première consultation, lorsqu'on fait le député de la grossesse et s'il évolue, à ce moment-là, il faut demander le bilan, il faut demander la sérologie de l'ARN. Il faut savoir interpréter de façon rigoureuse les sérologies. Donc, demander la première sérologie, le taux d'IgG initial, et refaire un deuxième taux.

(9:34 - 10:02)

Si le taux d'IgG est presque constant, donc là, on est sûr, si c'est positif, bien sûr, et si c'est constant, on est presque sûr que la femme est immunisée. S'il est négatif, il faut que ça soit, il faut que ça reste négatif. Donc, les résultats négatifs, ça veut dire la femme n'est pas immunisée, donc il faut surveiller jusqu'à vingt semaines d'amenorrhée tous les mois.

(10:04 - 10:31)

Alors, les résultats positifs, les taux sont stables, ça veut dire la femme est immunisée. Si les taux sont croissants, il faut poser la question, est-ce que c'est une primo-infection? Et là, c'est nécessaire de demander les IgM pour confirmer s'il y a une primo-infection ou pas. Si les IgM sont négatifs, à ce moment-là, la primo-infection est exclue.

(10:31 - 11:09)

Donc, peut-être que la femme n'a pas fait le prélèvement dans le même laboratoire, ou peut-être qu'il faut demander les IgM dans un autre laboratoire. Si les IgM sont positifs, on peut céder les techniques récentes, donc le dosage des IgA, ou bien demander l'habilité des IgG. Si les IgA sont positifs, avec une habilité IgG faible, inférieure à 50%, on peut confirmer la primo-infection et on peut proposer une interruption médicale de la grossesse.

(11:10 - 11:29)

Bien sûr, après consentement des patients. Que faire lorsqu'une primo-infection est mise en évidence à 32 semaines d'amenorrhée? Donc, il faut rassurer la patiente. Il faut la rassurer qu'il n'y a pas de risque de photopathie, puisque ça dépasse 18 semaines d'amenorrhée.

(11:30 - 12:13)

Mais, à la naissance, on peut faire une sérologie chez l'enfant pour voir s'il est infecté ou pas. Donc, une primo-infection urbiolique, avant 18 semaines d'amenorrhée, insiste ou bien le cas de la patiente peut être discuté dans un staff multidisciplinaire. Bien sûr, il faut discuter, après consentement des parents, la possibilité d'interruption médicale de la grossesse, puisque cette maladie peut donner des manifestations ou bien des malformations graves chez le fœtus.

(12:14 - 12:50)

En conclusion, on insiste sur l'importance de la vaccination des enfants, et si les enfants ne sont pas bien vaccinés, à ce moment-là, il faut généraliser la vaccination chez toutes les patientes en âge de procréation. Pensez à la sérologie préconceptionnelle ou bien précocement au cours de la grossesse. Donc ici, j'insiste sur l'intérêt de la consultation préconceptionnelle, chose qu'on ne fait pas souvent ici dans notre contexte.

(12:50 - 13:15)

Les patients qui tombent enceintes sont bien sûr consultés par leur médecin de famille ou bien leur médecin de quartier. Donc, il faut toujours sensibiliser ces patientes pour l'intérêt de la consultation préconceptionnelle. Et bien sûr, si la femme est enceinte, il faut éviter tout contact avec un enfant porteur d'une éruption.

(13:17 - 13:18)

Je vous remercie.